学生跑者伤病检索手册

伤病 · 训练 · 复健 · 心理调节

给心气还在、也想长期健康跑下去的学生跑者

powered by captainwang

目录

前言……2

1 不致停休数周的小伤……3

1.1 跟腱炎……3

1.2 胫骨骨膜炎……4

1.3 肌肉拉伤……5

1.4 髂胫束综合征……5

2 需要停休数周数月的大伤……8

2.1 下腹疼痛……8

2.2 髌下脂肪垫炎……8

2.3 鹅足滑囊炎……12

2.4 髌腱炎……12

3 习惯性岔气……13

4 伤中的心理调节……15

4.1 停跑焦虑……15

4.2 需要耐得住寂寞……15

5 伤愈后复健……16

5.1 复健总原则：慢……16

5.2 复跑计划……16

6 玄学……17

6.1 赢完别飘……17

6.2 不要半场开香槟……17

6.3 玄学在我身上很应验……17

powered by captainwang

前言

编者是一位目前大二的长跑爱好者，从 2024 年 3 月开始跑步到现在 27 个月有余，只有 15 个月的时间在规律跑步，剩下的 12 个月都在经历需要完全停休的伤病折磨，算上每次重开所需要的时间，可能只有 8 个月的时间在“训练”，因此我的进步十分缓慢，每次状态正好的时候突然受伤被迫停休数月，都是对心理健康的很大打击，但我依然没有被浇灭热情，伤愈后一次次耐心的从 0 开始重开。因为我享受竞速的感觉，没有什么体育项目比跑步能更简单迅速的获得快乐。我喜欢花样滑冰，但等我通勤几小时到最近的冰场，换上冰鞋，换身衣服，这些时间就已经足够跑完十几二十公里了。南体就在宿舍门口十几步路的位置，方便换上跑鞋随时开始跑步的同时也是个 penalty，因为在受伤的日子里我每次出宿舍门，看到操场上的人们在健康地运动都会应激，像一个刚刚结痂的伤口被无情撕开。

众所周知，如此经常的受较为严重的伤病在学生跑者中是非常罕见的，因为我们训练量和强度并没有那么夸张，但不得不承认这和遗传因素，睡眠质量，饮食结构有着非常非常紧密的联系，当然最主要的因素是前者。其实在康复上编者已经氪了很多金，包括但不限于各种化学药物（洛索洛芬钠、氟比洛芬、扶他林 2%版、云南白药气雾剂、筋骨伤喷雾剂）；理疗仪器（家用超声波、红外理疗仪、艾灸盐袋）；放松仪器（全套筋膜刀、两台爱跑猫筋膜仪、麦瑞克筋膜枪 m028）。即便如此还是伤病频发，足以证明我有多不适合这项运动了。

想要开始写这本所谓《伤病手册》的决定来自于我的最近一次大伤，它在某种意义上完完全全重建了我对长跑这项运动的认识。因此我虽然不是一个成熟的跑者，或者说我的认知仍然停留在一个非常初级的阶段，但我仍然认为我已经走过了太多的弯路，想写点什么记录下这些经历，给同样脆皮的跑步爱好者（尤其是女性）一些经验和启发，以绕过这些坑，早日达到心中的目标，健康快乐跑下去。

powered by captainwang

这是一本词典性质的伤病检索手册，由我和几位 irun 的同学根据真实经历写下，希望能给即将受伤或希望尽可能规避伤病的 iruner 一些帮助。当然，下面的内容或许掺杂着个体差异性，对 A 有效的方案可能对 B 没那么有效，因此需要辩证看待，仅供参考。

最大的感悟可以凝练成 3 点（当然是针对比较脆皮的跑者，天赋型选手无需参考 hhh）：

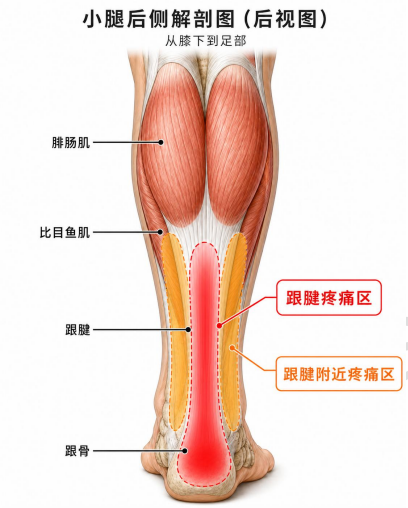
1. 循序渐进地加量，切勿急于求成，切勿和他人对比，天赋和恢复速度各有差别；
2. 力量训练不能盲目发力，要平衡各对拮抗肌的刺激，一旦力量水平不平衡又会引发严重伤病（尤其是膝盖这个敏感区）；
3. 聆听身体的声音，体感疲劳时切勿强制开机；
4. 放松一定要勤做，即便我捏着这块肌肉已经足够松软，也必然不代表他没有长期处于紧张状态（亲测），即便我觉得不需要放松也要充分借助筋膜枪等手段放松，尤其是大腿的大肌肉群。这意味着时间成本的骤增，但没办法，我既脆皮又想要竞速，没有天赋是这样的。

1 不致停休数周的小伤

人类的身体构造及其精密复杂，肌肉筋膜经络纵横交错，可能产生伤病的部位也数不胜数，但有些伤病是可以通过减量调整配合积极治疗在运动中康复，有些伤病则必须严格停跑休息，否则只会越拖越大，造成严重后果。本章主要介绍的是前者那种不致完全停休的小伤。

1.1. 跟腱炎

跟腱炎是最常见的伤病之一，只要采取科学的措施，通常来得快去得也快。需要注意的是，这种疼痛分为跟腱疼痛和跟腱周围的肌肉疼痛，即脚后跟（跟骨正后方）和跟腱及附近相关肌肉筋膜的疼痛。体感上通常是拉伸感强烈，上下楼梯痛，走路痛，或旋转脚踝受限，有别着的感觉。但它们的处理方式是类似的。



powered by wywang

跟腱炎的病因往往是小腿后侧肌肉紧张，初次发生疼痛前就需要每次跑完后都用泡沫轴充分放松整个小腿后侧肌肉（当然不是只放松这一个部位，这只是针对跟腱问题的预防，这个后面还会提到），分为正和两个侧这三个面来滚，做到小腿不受力时用手捏捏跟腱发现是松软的，没有和左右两侧的肌肉产生粘连，就达到一个比较理想的状态了。

但即便如此依然有可能产生疼痛，原因是泡沫轴并不能对积攒的长期紧张或更深层次的肌筋膜进行放松，这时就需要筋膜刀辅助捋顺筋膜，松解筋膜粘连，从而起到消除疼痛的效果。筋膜刀放松小腿的教程在互联网上有很多，这里不再赘述，个人经验是刮到位的标准是站姿弓步拉伸小腿时拉伸感转移到靠近小腿肚的位置，即小腿上半段。

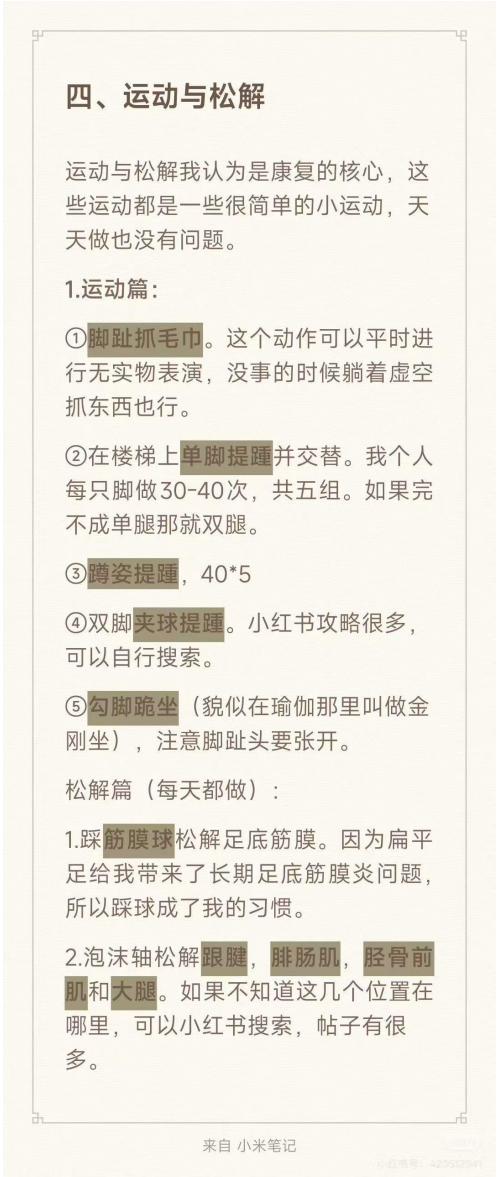
放松到位后，小腿可能会有肿胀，淤青，这些都是正常现象，一般第二天疼痛就会有明显改善，期间无需停跑，只需适当降低强度。关于练习哪些肌肉来规避这个问题，可以到互联网寻找答案，一般就是各种花式提踵，这里不再赘述。

——by wyw

1.2. 胫骨骨膜炎

这是一种可大可小的伤病，如果不作及时处理和适当减量，可能造成需要停跑数月的严重后果，对日常起居生活造成不便，甚至引发应力性骨折。

大多数情况下，骨膜炎的诱因是突然加量或体重不适合当前的训练量，前者建议及时减量，按照周负荷增长不超过 10%的速率逐步提高负荷；后者建议及时减重或以更缓慢的速率加量。此外，扁平足也是骨膜炎的重要诱因，如果你像我一样在小时候没有及时获得干预，矫正足弓，那只能定制足弓垫或穿有足弓支撑的慢跑鞋（如索康尼坦途，亚瑟士 gt2000 等）来慢跑，尽可能矫正落地步态。也可以在平时的走路鞋里塞上半掌足弓垫，使这种足弓顶起的感觉渗透到生活的每一步，形成习惯。当然，脚底力量也至关重要，这个在老王的经验贴里可以获得不少启发：



四、运动与松解

运动与松解我认为是康复的核心，这些运动都是一些很简单的小运动，天天做也没有问题。

1.运动篇：

①脚趾抓毛巾。这个动作可以平时进行无实物表演，没事的时候躺着虚空抓东西也行。

②在楼梯上单脚提踵并交替。我个人每只脚做30-40次，共五组。如果完不成单腿那就双腿。

③蹲姿提踵，40*5

④双脚夹球提踵。小红书攻略很多，可以自行搜索。

⑤勾脚跪坐（貌似在瑜伽那里叫做金刚坐），注意脚趾头要张开。

松解篇（每天都做）：

1.踩筋膜球松解足底筋膜。因为扁平足给我带来了长期足底筋膜炎问题，所以踩球成了我的习惯。

2.泡沫轴松解跟腱，腓肠肌，胫骨前肌和大腿。如果不知道这几个位置在哪里，可以小红书搜索，帖子有很多。

来自 小米笔记

全文可以跳转链接 http://xhslink.com/o/1bj3hEXr96l

进一步学习

疼痛来临时，可以在急性期冰敷，一周后热敷，使用红外理疗仪边照边涂扶他林消炎。此外，放松胫骨后肌往往有比较明显的作用。

从个人经历来看，胫骨前肌力量不足也会引起骨膜炎，不能单单只练提踵，必须增加胫骨前肌的训练才能平衡，我觉得比较有效的一个动作是脚尖插入壶铃中坐姿勾脚。并且，扁平足并不会“终结”你的跑步生涯，切勿自怨自艾，你可以理解为自己的身体构造不适合长跑，只需要花费比普通人更多的时间更长的精力就可以克服，它完全不意味着你不能通过足底和小腿的力量训练来规避掉扁平足的影响，我就是一个例子。

by captainwang

——by wyw

1.3. 肌肉拉伤

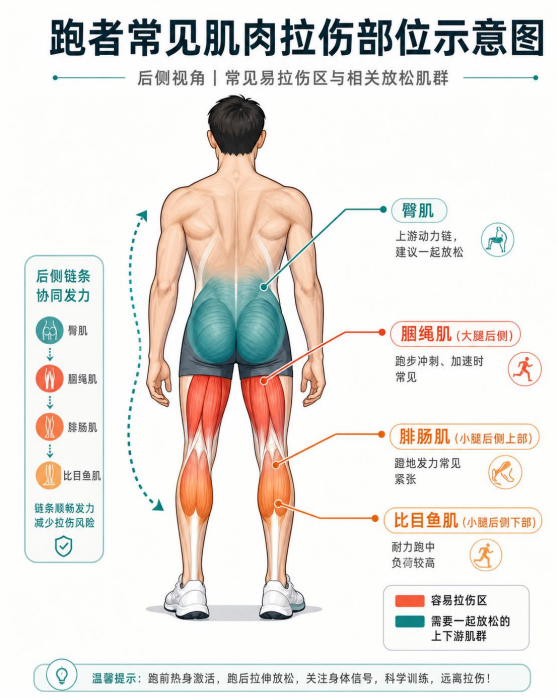
容易拉伤的肌肉有很多，最常见的就是腘绳肌拉伤。当然我也经历过缝匠肌拉伤、胫骨前肌拉伤、趾长伸肌拉伤、腓肠肌和跖肌上端拉伤，等等。拉伤不是循序渐进的劳损伤，没有提前的预警，而是在某一次明确的刺激后突然引发的疼痛。轻一点的拉伤只是酸痛、牵扯、发力不顺，重一点会有明显刺痛、局部压痛，甚至走路、上下楼、抬腿都会受限。

判断它是不是普通酸痛，一个比较简单的办法是看疼痛是否“定位明确”。普通延迟性酸痛往往是一大片肌肉都酸，热身后会缓解；拉伤则常常是某一个点或某一条线很明确，按下去痛，或者做特定动作痛（无论这个动作有多奇怪），尤其是让这块肌肉主动收缩或者被动拉长时更痛。比如腘绳肌拉伤，常见表现就是大腿后侧某个点牵扯，下楼梯、抬腿、弯腰摸脚尖、蹬地时会更明显。我用来形容腘绳肌拉伤的感觉是，坐在一个高凳子上两脚悬空并放松，向前踢腿后来回荡小腿，会感到大腿后侧在和凳子面接触压力变化的过程中感到刺痛，或难以描述的什么地方别着的感觉。

拉伤的处理流程基本是类似的，首先也是最重要的一步，就是充分按摩松解开拉伤部位，充分地对其进行刺激放松，引发肌肉的二次炎症，刺激机体自我修复机制。伤后越早进行这一步，越有利于康复进展的加速，这个过程一定很疼，但忍忍是为了加速康复。

二次炎症诱发后，可以使用洛索洛芬钠或氟比洛芬凝胶贴膏对疼痛区域进行全面积的覆盖，坚持贴 3 天以上就会很快见效，头几天可以停跑，但不要担心，肌肉拉伤在正确处理下的康复远比你想象的要快很多。但是很重要的一点是，松解开之后这块肌肉一定有很强的拉伸感，但切勿着急去拉伸他，此时拉伸只会让之间静养所花费的时间功亏一篑

powered by caiyan-wang



在这里，不妨回顾一下我所经历过的拉伤原因，这个诱因通常是很明确的。腘绳肌拉伤是在我的首半马最后 1km，由于刚开始跑步没多久，严重缺练，半马这个强度对我来说过于大了，所以彼时全身肌肉已经极度僵硬，在这种情况下依然盲目冲刺，导致了后侧链拉伤。还有一个比较有意思的点，想到啥说啥了，首半马后全身难受疼痛的感觉是不言而喻的，但随着跑步年限的增加，跑完半马后的不适和疲劳感会越来越减轻。

——by wyw

1.4. 髂胫束综合征

这也是一种相当常见的伤病，但它通常是能及时控制住的小伤，前提是你真的及时控制，而不是一边喊膝盖外侧疼一边继续跑量、跑强度。髂胫束综合征最典型的疼痛位置在膝盖外侧，有时像针扎，有时像摩擦发热，有时则是一种很烦人的牵拉痛。它也可能不只出现在膝盖外侧，而是从髋外侧、大腿外侧一路到膝外侧都有紧绷感。很多人第一次出现时会误以为自己半月板坏了、韧带出问题了，非常紧张，但如果疼痛主要集中在膝外侧，并且在跑到某个距离后逐渐出现，停下来走一走又缓解，就很符合髂胫束问题的特点。

它的病因并不是简单的“髂胫束太紧”，更准确地说，是整个髋—膝—踝链条的控制能力不够。尤其是臀中肌、臀大肌、阔筋膜张肌、股四头肌外侧头、内收肌群和小腿外侧的协同出了问题，导致跑步时膝盖和大腿反复出现细微的内扣、外摆或横向晃动，髂胫束就会被迫承受过多张力。跑量突然增加、下坡跑太多、操场永远同一个方向绕圈、鞋子支撑不合适、臀腿力量不足，都可能成为导火索。对于本来就比较脆皮、恢复慢、肌肉容易紧张的跑者来说，它更像是一种“结构报警”：不是单个地方坏了，而是整个下肢力线开始抗议了。如果不坚持加以谨慎的处理，很可能引发大祸，伤及半月板和交叉韧带！

powered by captainwang

需要注意的是，放松时“哪疼滚哪”是不可取的。髂胫束本身更像一条很厚、很硬的筋膜带，不是普通肌肉，拿泡沫轴死命压大腿外侧，往往只会把自己疼得龇牙咧嘴，却不一定真正解决问题。比较合理的做法是把重点放在牵拉它、影响它张力的肌肉上。互联网上的教程大多会强调放松阔筋膜张肌和臀中肌，这确实有用，但个人经历告诉我，如果只处理这两个地方，而忽视股四头肌外侧头、内收肌群、腓肠肌和足底，后面训练里很容易把问题转移到膝盖其他结构上，比如脂肪垫、髌腱、鹅足、半月板附近，最后从一个相对好处理的小伤变成真正令人头疼的大伤（亲测。。。）



个人体验来看，家用超声波对于髂胫束部位的疼痛非常有效，可以切身可感地看到它的消炎作用，并且体感温和，就是操作有些麻烦。我买的就是下图这种仪器，大概不到三百块钱，每天每块患处打 5 到 10 分钟，肌肉筋膜可能感觉不大，甚至毫无感觉，让你怀疑买到了假机器，但别担心，家用超声波就是这样的功率，但它也确确实实地有效果。但如果用它来打附着在骨骼上的软组织又是另一种体验了，会有一种非常怪异的酸胀麻痛感，像触电一样，有的人可能无法忍受。

powered by cabtainwang



——by wyw

2 需要停休数周数月的大伤

2.1 下腹疼痛

如果女性在某次跑步后突然感到在骨盆以下的位置，左/右下腹隐隐作痛，跳跃和跑步都会感到颠着疼，就像是肚子里有个装满了水的气球跟着你的活动一坠一坠的。随着时间的推移，逐渐变成针扎的疼痛，每走一步都像肚子里打碎了一个玻璃杯，玻璃碴子四处飞溅后扎在腹腔上。可能是发生了腹腔出血，应当及时就医并严禁热敷，热敷只会加剧毛细血管的破裂，让病情恶化。

如果此时就诊的医疗检查并未报告任何问题，但你已经感觉到明显的疼痛，请怀疑医生而不是怀疑自己，即刻更换医院继续做检查，直到发现问题为止。事实证明误诊真的存在，导致症状越拖越大，直至住院或做手术，带来不必要的麻烦，都是血泪的教训（哭晕）。

这个康复的周期可能会相当漫长，但是因人而异，我花了整整 8 个月的时间才康复到无痛奔跑的状态，但有的人只需 1 周时间。我觉得加速恢复最好的办法就是保持心情放松，这样才能加快代谢。在日常活动不被疼痛影响的前提下，可以尝试慢慢恢复龟速跑，可以使用下面这种加压腰带，可以显著减轻疼痛，稳定核心。

powere hwang



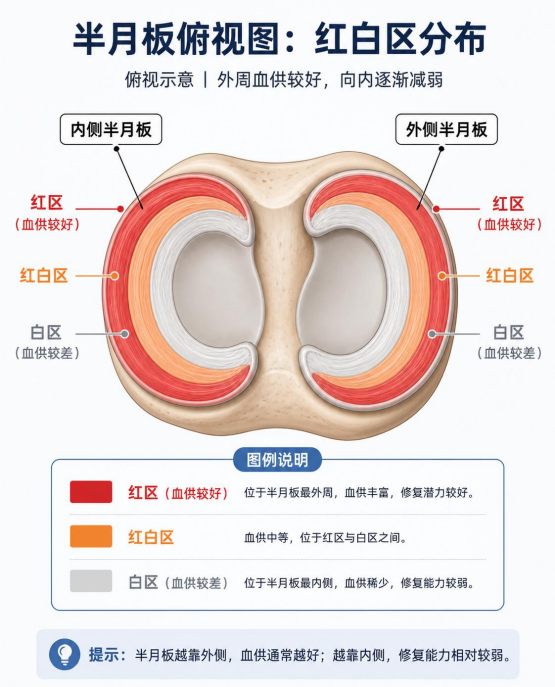
——by wyw

2.2 髌下脂肪垫炎

从这里开始我们就正式进入了膝盖问题的章节，跑步伤病中分三档，第一可怕的是心脏等内脏器官的疾病，第二可怕的是膝盖，其他伤病在前两者面前只能归为洒洒水的小事。

为什么膝盖伤这么可怕？最最主要的原因的半月板和韧带由于供血不足，一旦发生损伤就需要相当长的时间才能康复，就算不是这两处受损，简单的膝下滑囊炎也需要相当长的时间才能代谢出去，并且

期间必须严格制动，一步也不能跑。更麻烦的是伤到交叉韧带和半月板的白区，这些地方没有血供，几乎难以自我修复。



这种伤病就是刺激我写下这本手册的原因。我在这次意外的伤病中第一次意识到放松一些看似无害的肌肉有多重要，平时一些看似无害的生活习惯有多危险，正确的治疗措施对降低损失有多关键，以及平时一心向善地积攒人品有多必要。

powered by captainwang

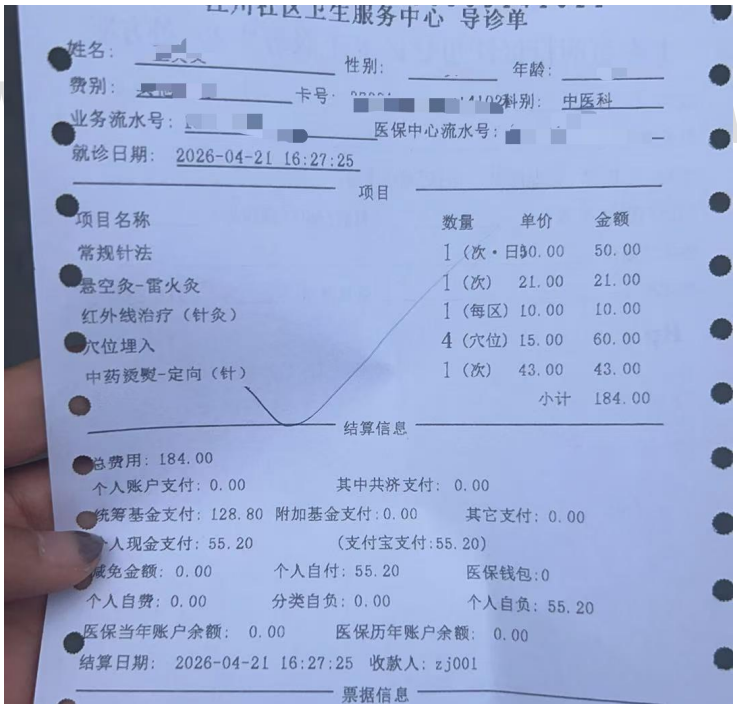
不妨来回顾一下这场惨案，全过程中踩的无数个坑我会在括号中标注，或许会对读者有一些警示。（如果不想阅读这部分，可以直接跳转到下方反思环节）

困扰了我 2 个多月的髂胫束问题在我跑完一场半马目标赛事之后莫名其妙的彻底痊愈了（其实本来比赛前夕就已经基本没感觉了），但这场比赛在多个 debuff 因素的加持下赢的非常吃力。倒霉的是我在 pb 后并没有感到肌肉关节的任何不适和异样，赛后两天才认真滚了一次泡沫轴（我的泡沫轴是狼牙棒版），按照常规流程滚了经典的阔筋膜张肌、臀中肌、跟腱附近的肌肉（这是第一次踩雷）。为什么说这是倒霉的事？因为由于没有任何身体部位有不适感，我遗漏了很多看似无害的肌肉的放松，这在这场意外发生之前我是打破脑袋也必定想不到的，真悲哀。

赛后的一周里，我开始以每天 5k 的速度慢慢恢复，但感觉力不从心，全身疲惫（第二次踩雷）。由于后面还有 3 场比赛，我在赛后第一周的周六跑了一个小强度想激活一下全身，以便快速恢复状态，悲剧发生了。由于天气炎热，我在间歇的组间漱了漱口，按照平常的习惯我是会站着对着下水道的大概方位直接吐了，但可惜当天有喜欢的学姐和我一块跑，我不好意思直接吐水，这样显得我很没素质，所以我选择谦卑地蹲下去，对准下水道的缝隙，准确地吐进去，然后优雅地站起身来，向前走了一步，突然发现不对劲。左膝外侧在走路时有尖锐的刺痛，但是手表的计时就要结束了，按照计划我们要在 3 秒后开启下一组，我没当回事，立马就掐表开始跑了，结果令人开心，跑起来似乎并没有任何痛感，甚至感觉状态越跑越有（第三次踩雷）。

从冷身到拉伸到去食堂吃饭的整个全过程，左膝都再也没疼过，就在我几乎已经忘了这个小插曲，走在回宿舍的路上时，左膝外侧突然开始每走一步都严重刺痛，坐姿抬（伸直）腿这个动作也非常非常痛，我确认不是髂胫束的那种膝盖外侧疼痛，因为这个痛点在外侧膝眼和胫骨最上头的位置。我慌了，在不断的 ai 问诊中选择休息一天 ，冰敷了一会，贴了洛索洛芬钠，打了超声波后睡了一晚，但是第二天并没有任何缓解。我选择去健身房做我的《给你的膝盖做个大保养》系列力量训练，寄希望于借助肌肉的刺激来缓解疼痛（第四次踩雷），更欠揍的是我每一个动作都选择给自己加码，平时根本不会负重的动作在这次都额外负重了 2 个 5kg 的哑铃，感到全身充满了 power，肌肉力量得到了质的升华！（真的很想穿越回那时抽 4 自己。。）令人欣喜若狂的是，练完全套动作之后顿时感到膝盖不疼了，那一刻感到自己是天才，竟然想到了这么绝妙的方法来治病！但当晚睡觉前又重新开始熟悉的疼痛，和原来一样，我没有气馁。因为我感觉这是小问题，下蹲、上下楼、跑步都没有疼痛，只有走路和抬腿会疼。

第三天依旧停休贴膏药，过了 48h，我开始尝试红外理疗仪热敷，可以说这是急性损伤的 routine 了，急性期过后用热敷来加速血液循环。神奇的是热敷完竟然一点也不疼了（第五次踩雷），我暗喜，以为自己又找到了治病的正确操作。但第四天早上起来似乎变得更严重了一些，跑步和上下楼也开始疼了！我彻底慌了，并且丝毫没有意识到这是热敷惹的祸。此时突然回想起之前有同学崴脚后的第三天到社区医院中医科扎了几针，感觉效果很明显，因此我下午下了课后匆匆赶到这家医院，进行了如图的治疗（第六次踩雷也是最大的雷！！！）



这个大夫给我开了非常多的项目，可惜她的针法极其差劲，扎在我半月板缝隙和膝盖周围的地方，可以说是哪疼扎哪了，拔针的时候流了很多很多血她也没意识到，直到 10 分钟后摘下电极片才发现我的血已经把整个电极片反面浸透了。她嘱咐我最近不要运动，并给我在膝盖上埋了很多小针，就是单子里的穴位埋入针，其中一根埋在了外侧膝眼的脂肪垫处。还没到宿舍我就感到胀痛难忍，把小针全拔了，发现脂肪垫处已经出了很多皮下淤血并且越来越肿，我感觉完蛋了。

我决定明天去做核磁，好在互联网医院线上复诊一个冷门科室，约到了次日早八的核磁。做完核磁后直接去找医生，他说没大事，开了青鹏软膏和一种非甾体类消炎药就让我去做做冲击波回家歇着去了，此外再没有给我任何帮助康复的忠告。做完冲击波后的两三天非常非常疼，几乎无法走路，我只能拄着拐杖走路，之后的三场比赛更是想都不敢想了，当时还是非常崩溃的。没想到更崩溃的还在后面。。。第二天核磁报告正式出来之后，报告了这么多医生没告诉我的毛病：

1.左膝内外侧半月板后角变性。
2.左膝前交叉韧带变性。
3.左膝少量积液。髌下脂肪垫略肿胀。

看到韧带和半月板这五个字的时候，我感觉天塌了，因为正如前文所说，这些供血不足之处的损伤是不可逆的。我只是业余爱好跑个步而已为什么会受这种篮球羽毛球攀岩级别的伤！？实在是太诡异了！
在几位医生朋友的点拨下，我意识到可能需要进行深度的肌肉放松才能治病，我先自己捏了捏股四头肌下端靠近膝盖的地方，虽然并没有感到肌肉紧张和僵硬，甚至手感还是软软的，但按压股四头肌外侧头会扯着整个膝盖外侧的筋膜都开始剧痛，我决定去阳光中医找按摩师帮助放松。

第一次他对胫骨前肌和腓肠肌的上端进行深度放松和拨筋，我随即就能脱离拐杖正常走路了，从没想到一次治疗可以起到这么立竿见影的效果；第二次他处理了大腿前侧和髋部肌肉，让我弯腿不再受限（虽然走路和弯腿还是很疼）。

考完期中后（发病一周后），我去了一家运动康复机构（复动肌骨），专业的康复师对我的左腿进行评估、理疗、肌力测试，最终找到了受伤原因：半月板和韧带“变性”意味着出现了微小的纤维撕裂或水肿，这都是小伤，并且现在都已接近痊愈，不会导致疼痛，疼痛来源于膝下脂肪垫炎症，大约需要 2 到 3 周可以逐步恢复跑步，病因是 1.大腿前后侧，臀大肌力量过强，或者说大腿内侧，臀中肌力量过弱导致下肢力线内扣，反复摩擦膝盖外侧筋膜和脂肪垫导致发炎，下蹲时膝盖承受全身体重，加上当时在跑间歇肌肉很紧张就损伤了前叉 2.损伤后两天开始热敷烤灯迅速加剧炎症反应 3.平时没有及时放松大腿前侧股四肌肉导致僵硬牵扯筋膜，导致那次下蹲时发病。

虽然现在这 2 周还没过去，我还没能重新开始跑步，未来的两场比赛是否能参加也完全是未知数，但我想这个过程中还是有很多可以规避的坑，比如上文提到的 6 次踩雷，让我来忏悔一下：

- 泡沫轴即便是狼牙棒也并不能起到深度放松的作用，它只适合日常放松，每次跑完步都滚一滚，消除肌肉紧张疲劳的累积。但在跑完一场高强度训练课或明显感到哪里不对头了的时候，泡沫轴是起不到作用的。又考虑到平时在宿舍里滚泡沫轴需要在狭小的四人间过道里铺开瑜伽垫，非常麻烦的同时又效果不佳，所以我认为筋膜枪是更好的放松选择。一个好一点的筋膜枪可以刺激到深层的肌筋膜，买的时候以推力参数为参考，一般 30kg 以上的推力就能起到很好的效果，我买的是 40kg 的，劲更大一些，下图是一个好的筋膜枪所起到的视觉效果，就是波纹状的感觉：

powered by capuinwang



决定换用筋膜枪还有一个原因，就是我发现每个人的身体构造、柔韧性、活动度千差万别，对我有效果的拉伸动作可能对你没有效，但你说你的这个部位就没有处于紧张状态，需要放松吗？并非如此，这种情况更危险更应该放松，而筋膜枪就是解决这个问题的点对点利器。

- 体感疲劳的时候千万不要强制开机，即便身体没有任何疼痛都不要强制启动，因为随时可能出现意外，参考上面的经历（无力）
- 出现异样的疼痛后立刻停止训练，不要强撑着坚持完成训练计划，这无非只是可笑的自我感动，让状况恶化，得不偿失。这点应该学习老詹，他在好几次间歇日，只跑了一两组甚至刚刚热身不到 2km 就感觉哪里疼或不舒服，然后立刻停下，干脆不跑了直接练力量，休息一天就没事了。可以看出，身体的累积疲劳是一块定时炸弹，在初见端倪时及时剪断几根电线，就可以避免它的爆炸。
- 膝盖周围出现持续不消退的疼痛后，立刻停止一切蹲类的力量训练，此时的刺激只会引发炎症和水肿，让康复时间指数级增加。把这个告诉一个月前的我，我是怎么也不可能相信的，但受伤后和 3 位曾经受过膝盖伤并且已经康复的同学交流，发现他们普遍反映了这同一个问题，就是疼痛期练力量会恶化！可能练完的当下没有感觉不适，甚至因为局部温度升高，血液循环加速而暂时压制了疼痛，但第二天疼痛必然会恶化，切记切记。
- 冰敷为主，尽量不要热敷。其实我至今也没有搞明白冰敷和热敷应该怎么选择，按照常识就是应该 24h 后开始热敷，加速血液循环，但前提是患处没有发生水肿，如果已经肿起来了那只会越热越肿，且刚热敷完很舒服，一点也不疼了，镇痛原理和练力量差不多，但第二天只会越来越严重。所以我目前总结下来的应用就是尽量冰敷，不要热敷。冰敷怎么说都不会导致问题恶化，而热敷不当是会起反作用的，当你感到焦虑恐惧想做点什么的时候，请冰敷消炎吧。
- 针灸是好东西，真正懂中医的人来施针灸之法确实能帮助恢复（亲测），但问题就是现在真正“会”针灸的医生太寥寥无几了，我最大的悔恨就是随便找了个不懂中医的人操作我的膝盖！所以除非你了解这个医生，否则切勿随意尝试针灸，这就是在开盲盒了，碰到好医生就会起到很好的治疗效果，碰到半吊子医生就彻底寄了，所以还是不要拿自己的身体去碰运气了。

——by wyw

powered by caijianwang

2.3 鹅足滑囊炎

2.4 髌腱炎

3 习惯性岔气

这是困扰很多初跑者的一种常见问题，常发生在肋间，它不算一种伤病，但疼起来很烦，会极大的增加比赛发挥的不稳定性，因为一旦开始岔气就会疼痛难忍。症状严重者在走路或上楼梯时都会出现岔气，多频发于天气转凉的时候。

我是在一次 1000m 间歇的最后一组中途发生右侧肋间岔气，非常疼，但我当时没有领悟到上文中提到的“出现异样的疼痛后立刻停止训练”，强撑着自我感动，用手死命掐着肋间完成了训练计划，从此以后这同一个位置就经常出现习惯性岔气。最严重的有一次比赛最后 1km，疼到无法呼吸，直接从 4 分配掉到 6 分配，狼狈完赛。每次比赛前也徒增很多不必要的担忧，因为一旦习惯性岔气了，不论怎么充分地做准备活动都是一样的会岔气，很头疼。所以吸取教训，还是不要在某次岔气后硬顶了，说白了还是自我感动。

但在日复一日的摸索中，我发现了解决习惯性岔气的方法。分为松解、预防、强化三步走。

1. 松解：首先需要对习惯性岔气的那块肋间肌进行充分松解，将缠结的筋膜捋顺开，让积攒已久的炎症尽快代谢掉。肋间肌是斜向肌肉，在按摩时应当横向刺激，将它揉开之后就会好很多。还有一种方法是运动康复师告诉我的，用毛巾包住一把木梳子，在岔气处的肋间肌施加压力，反复变换位置进行按摩。康复师说他之前接到过一个病号，很多年前摔了一跤，靠近锁骨的肋间肌总是反复疼，因为那里的炎症可以藏很长很长时间，松解开就好了。

powered by cantainwang

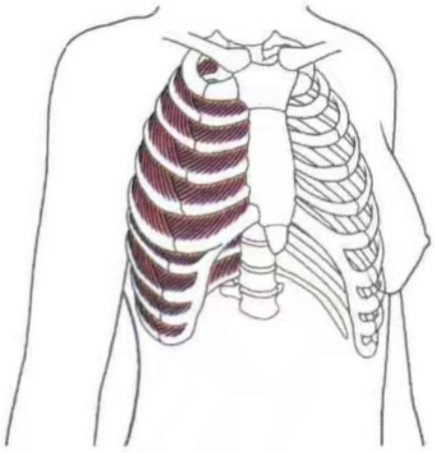


图 1–42　肋间肌解剖示意图



图 1–43　肋间肌贴扎

2. 预防：如果已经掉入习惯性岔气的怪圈，请在放松的同时贴扎肌贴，按照上图所示，沿着与肋间肌走向垂直的方向进行贴扎，可以起到很明显的预防岔气的效果（亲测）。

3. 呼吸是整个腹腔的任务，因此习惯性岔气归根结底是核心深层的激活有问题，所以还是需要练一练呼吸肌和深层核心肌群。腹式呼吸也很有效果，但腹式呼吸其实是整个腹部阶段正常呼吸，像一个气球一

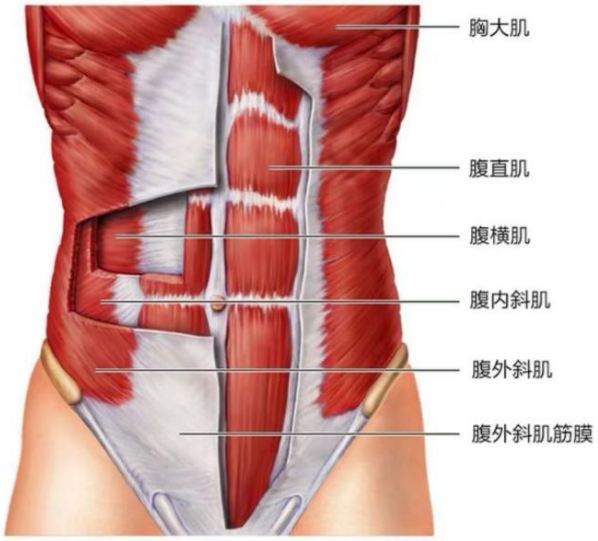
样，往四周都张开、四周都能收回来的，而不是只有肚子前后的运动，肺部完全不动，这不是腹式呼吸。关于深层核心肌群的训练，可以先来看看这组图片：





相信很多人都会有这样的体验，做仰卧起坐这类动作时总看到自己的腹肌处于左图的状态，这就是浅层核心发力的表现。

powe wang



腹部的解剖结构常常被忽略，但腹部对跑者的重要性完全不亚于腿部。我们可以看到腹部肌肉像奶油蛋糕一样分为三层，最浅层的腹直肌是我们常说的八块腹肌，腹外斜肌和腹直肌同属一层，第二层是腹内斜肌，第三层也是最内部的那层则是腹横肌，距离肋骨最近，和呼吸最密切相关，大多数的习惯性岔气的根因都是腹横肌力量不足。关于这块肌肉的锻炼，可以在互联网上查到很多相关教程，这里留待大家主动探索，但他们发力的核心原则都是一样的——不要让腹部发生鼓凸！

4 伤中的心理调节

4.1 停跑焦虑

受伤最折磨人的地方，往往不是疼痛本身，而是“我明明刚进入状态，却又被迫从跑者变成旁观者”。尤其是需要完全停跑数周、数月的大伤，最直接的打击就是心肺功能退化。停跑不是简单地少跑几天，它会让原本熟悉的配速变得陌生：同样的慢跑心率更高，同样的上坡更喘，同样的热身也不再轻松。你会明显感觉到身体在把过去辛苦建立起来的适应一点点撤回去，这种退潮感非常容易诱发焦虑。焦虑的核心不是“我今天没跑”，而是“我是不是又要从零开始”。这里必须把话说重一点：停跑对心肺功能退化的影响非常大，尤其对已经习惯高频训练的学生跑者来说，体感会非常明显。但是不排除有普通的学生跑者两周没跑不但没退化，反而还突然 pb 了，但这种天才我身边只遇到过个位数个，不要和别人横向比较，因为每个人的训练年限、伤病类型、睡眠、营养、激素水平、遗传恢复能力都不一样。你感到恐慌，并不代表你脆弱，它只是说明跑步在你的生活里占据了真实的位置，而身体能力下降又真实发生了。但也要记住另一半真相：心肺会退化，不代表心肺会永久消失。耐力的很多适应可以通过后续规律训练重新建立，只是它不会按你焦虑的速度回来。伤中最重要的心理任务，就是接受状态会掉，但拒绝因为害怕状态掉而提前复跑。焦虑不应该变成偷跑的理由，它应该变成你认真康复的提醒。

4.2 需要耐得住寂寞

powered by captainwang

受伤后最忌讳的生活方式，是白天忍着不跑，晚上突然崩溃，然后在操场边试两步，或越想越委屈越来越难受最后大哭一场（这点我比谁都熟悉，因为我还经历过一次被宣判再也无法跑步的大伤）。为了避免被情绪控制，需要提前把每天可以做的事写下来。可以把一天拆成三个固定模块：第一，身体维护，包括冰敷或热敷的选择、药物或理疗、康复动作、轻柔放松；第二，生活恢复，包括睡眠、饮食、补铁补蛋白、减少熬夜；第三，心理安放，包括写伤病日志、和家人朋友交流、暂时减少刷比赛动态。只要这几件事完成，就算今天没跑步也没学习，这一天也不是“废掉的一天”。伤病日志不需要写得很复杂，建议只记录五项：疼痛位置，疼痛等级，今天做了什么处理，明天是否需要减少活动，以及一句真实情绪。最后一项非常重要，因为很多伤病恶化不是来自不知道怎么处理，而是来自情绪把人推向崩溃。

我个人的习惯是一旦开始大伤停跑，就把手表放到盒子里完全不看它，免得被“训练状态”和“预测成绩”栏里的微小变化折磨。此外我还会折叠微信里所有和跑步有关的群聊，免得看到消息或新比赛缺无法参加时心里难受，当然这种逃避的处理方式其实并不可取，但我想不到什么更好的掩耳盗铃之法。

5 伤愈后复健

5.1 复健总原则：慢

伤愈后最危险的时刻，不是疼得最厉害的时候，而是刚刚不疼、以为自己好了的时候。疼痛消失只代表炎症或刺激下降，并不代表组织承载能力已经回到受伤前。很多复发都发生在这个阶段：走路没事，上下楼没事，于是立刻恢复原来的配速、跑量、间歇，结果两三周后同一个位置再次爆炸。所以我的复健原则是：大伤重开后，必须先进行至少一个月的纯慢跑，再逐步上强度。这里的“纯慢跑”不是“我觉得不快”，而是全程能完整说话、心率和呼吸都可控、跑完不兴奋也不透支的慢。这个月的任务不是提升能力，而是让骨骼、肌腱、韧带、筋膜、关节滑囊和神经系统重新适应跑步冲击。不要把这一个月看成浪费时间。它是保险费。急着上强度省下的两周，往往会用下一次停跑两个月还回去。

第一周的目标是确认身体能接受跑步这个动作，而不是确认你还剩多少能力。建议从跑走结合或极短距离慢跑开始，比如跑 1 到 2 分钟、走 1 到 2 分钟，循环若干次；或者总时长控制在 15 到 25 分钟。跑步日之间至少留出一天恢复，任何患处刺痛、步态变形、第二天疼痛增加，都要立即退回上一档。第二周到第四周可以逐步延长慢跑时间，但仍然只做纯慢跑。不做间歇，不做节奏跑，不做冲刺，不做爬坡刺激。手表上的配速越难看越好，因为这说明你真的在给身体空间。此时最重要的指标不是配速，而是跑后 24 小时和 48 小时的反应：有没有肿胀，有没有跛行，有没有局部压痛，有没有熟悉的旧伤感。如果四周内出现反复不适，不要自我安慰“跑开就好了”。复健期的疼痛不是普通训练疲劳，它是在告诉你组织容量还没回来。正确做法是减少跑量、延长恢复、回到康复动作，必要时重新找医生或运动康复师评估。

powered by captainwang

我曾经有一次因伤停跑两个月后突然着急恢复，为了赶上联盟杯并拿到一个所谓好看的名次，现在看来十分愚蠢。我试图在没有恢复的情况下在比赛中跑两个月受伤前的配速，导致全程平均心率 210，身体受到损伤，腹腔出血，赛后就开始了下一轮为期 4 个月的受伤，两次大伤之间根本没有喘息的间隔，这是很惨痛的教训。

5.2 复跑计划

完成至少一个月纯慢跑，并且没有疼痛反跳之后，才可以考虑逐步加入强度。但顺序必须保守：先加总时长和周频率，再加少量变速感，再加坡，最后才是间歇和比赛配速。最不建议的做法，是刚能连续跑 30 分钟就立刻回到受伤前的训练表。第五周可以尝试在一次慢跑末尾加入 4 到 6 组 10 秒左右的放松加速跑，重点是动作轻松，不是速度快。第六周以后，如果没有任何旧伤反应，可以加入短坡或轻微渐进。真正的节奏跑、长间歇、测试跑，建议放在连续 6 到 8 周稳定慢跑之后再考虑。对于骨应力伤、膝关节伤、韧带或半月板相关问题，还应更保守。加量也要遵守“只改一个变量”的原则：本周如果增加了跑步天数，就不要同时加距离；如果增加了距离，就不要同时加配速；如果加入了加速跑，就不要再叠加强度课。复健不是展示意志力，而是进行精明的负荷管理。

6 玄学

6.1 赢完别飘

这部分叫玄学，但它并不只是迷信。很多伤病真的发生在一场非常满意、甚至大获全胜的比赛之后。原因很简单：赢得太爽时，人会自动高估自己的身体承载能力，低估比赛残留的疲劳。你会觉得“我状态回来了”“我终于练出来了”“接下来可以再冲一波”，然后在肌肉、筋膜、关节还没从比赛里完全恢复时，提前上量、上强度、报下一场，最后受伤。所以本手册的玄学第一条是：跑了一场满意的大获全胜的比赛后，决不能飘。一般飘了就会受伤。越是 PB，越是超预期，越是赢得漂亮，赛后越要把自己当成一个刚经历过高强度损耗的人，而不是刚获得免伤金牌的人。

比赛后的第一周，不要用兴奋感判断恢复。兴奋会遮盖疲劳，肾上腺素会让你误以为身体没有问题。正确做法是降低训练刺激，认真放松，补觉，观察关节和肌腱反应。如果一定要跑，也只跑恢复跑，不要安排任何“激活一下”“找找状态”“小小刺激”。很多大伤就是从这种小小刺激开始的（亲测）

6.2 不要半场开香槟

玄学第二条：不能提前开始总结自己已经获得的成就。比如“我已经无伤训练 8 个月了”“我这次周期很完整”“我最近状态特别稳”“我终于摆脱伤病体质了”。这些话不一定不能说，但一旦你开始认真总结，心态就容易从敬畏变成结算，从谨慎变成奖励自己。总结完往往就会受伤。这听起来很玄，但背后有现实逻辑。提前总结成就会让人默认当前阶段已经安全结束，于是放松对疲劳、睡眠、疼痛和训练波动的警惕。你会觉得“既然我已经这么稳定了，那这次稍微冒进一点也没事”。而身体并不知道你在总结，它只会按负荷、恢复和组织承载能力回应你。因此，不要在训练周期中途给自己颁奖。可以记录，但不要结算；可以开心，但不要宣布毕业；可以觉得状态好，但仍然按脆皮跑者的标准生活。真正值得总结的时间点，是安全完成恢复周、比赛周和赛后恢复之后，而不是在最容易飘的时候。

powered by captainwang

6.3 玄学在我身上很应验

对于脆皮跑者来说，最灵的玄学其实是“留余地”。训练留一口气，比赛后留一周，伤愈后留一个月，状态好时留一点敬畏。你少跑的那一点，可能就是你没有受伤的原因。所谓“一飘就伤”，往往是风险补偿、疲劳滞后和注意力下降共同作用的结果。状态好时，人更敢冒险；比赛后，身体疲劳常常滞后出现；连续顺利训练后，人又会减少放松、睡眠和疼痛监测。看起来像玄学，实际上是风险管理失效。所以这一章的结论很简单：赢完当输处理，顺完当险处理，无伤越久越谨慎。不要因为最近很顺，就忘了自己为什么曾经受伤。长期健康跑下去，不靠一次大获全胜后的豪言壮语，而靠每一次想飘时都把自己按回地面